

Fecha Última Actualización: 06-11-2022 17:54:30

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Berta Veronica Arancibia Aros
Edad : 67a 4m 2d
Dirección : Calle 1 #845, V. Ohiggins

Rut : 9.069.494-4
Fecha Nacto: 04/07/1955
Comuna : La Florida

N° Archivo : 1430210
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 8851 4602

N° Epicrisis
316790

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Recuperación

Fecha Ingreso : 22/07/2022 23:10

Días Estadía: 107

Unidad de Egreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji

Fecha Egreso : 06/11/2022 17:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dolor abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Fecha de ingreso HSR: 22/07/2022
Fecha de ingreso UPC: 28/07/2022
Fecha de egreso UPC: 08/08/2022

Antecedentes:

Mórbidos: cáncer ovárico etapa III (debut 2015 como adenocarcinoma endometrioide, QX + QMT de 3ra línea Doxorubicina Liposomal), hipertensión arterial

Quirúrgico: apendicectomía, histerectomía, salpingooforectomía bilateral

Medicamentos: Losartán, Amlodipino

Alergias: se desconocen

Historia actual:

Paciente con antecedentes descritos, con historia de dolor hipogástrico desde el día 22/07 intenso, opresivo, asociado a náuseas y deposiciones diarreicas. Consulta en SU HSR en buenas condiciones generales, normocárdica, normotensa. Se solicita TC de abdomen y pelvis que informa Aumento de tamaño de la masa sólido quístico pelviana en contexto de recidiva de su neoplasia primaria conocida, con aparente infiltración de la pared de la unión rectosigmoidea con signos de perforación y formación de una colección hidroaérea en el meso sigmoides, con leve neumoperitoneo supra meso cólico, moderada ascitis y cambios inflamatorios del peritoneo. Con sospecha de perforación intestinal se realiza laparotomía exploratoria, donde se evidencia peritonitis estercorácea en cuatro cuadrantes, asociado a la presencia de un tumor pelviano adherido al recto y múltiples implantes peritoneales. Se realiza colostomía terminal y se deja bolsa de Bogotá.

Se traslada a recuperación y posteriormente a UCI para continuar manejo. Ingres a grave, con uso de DVA para PAM > 65 mmHg.

Diagnósticos de ingreso:

Shock séptico de foco abdominal

Perforación intestinal neoplásica - peritonitis estercocácea

Cáncer de ovario metastásico

Antecedentes

Fecha Epicrisis : 06/11/2022 17:54

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:23

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 06-11-2022 17:54:30

Página 2 de 3

Evolución durante hospitalización:

Hemodinamia: con requerimientos intermitentes de DVA hasta dosis moderadas. Volemización según predictores dinámicos, posteriormente con clínica de sobrecarga de volumen como complicación de la reanimación.

Respiratorio: al ingreso a la unidad en VMI por shock séptico. Se mantiene con parámetros protectores con sedoanalgesia para favorecer acople. Últimas 24 horas en modalidad CPAP en contexto de sepsis severa persistente. Sin intercorrientes respiratorias, se realiza prueba de ventilación espontánea que resulta exitosa y se logra extubación 07/08.

Infeccioso: al ingreso con peritonitis estercorácea, se inicia Ceftriaxona + Metronidazol. Se rescata cultivo de líquido peritoneal (+) para Enterococcus faecium MS y Bacillus spp. Al ingreso a UPC séptica, se cultiva y se escala terapia a Imipenem + Vancomicina a dosis plenas. Persistentemente séptica pese a cobertura de amplio espectro, se adiciona Anidulafungina con mala respuesta.

Quirúrgico: se realiza aseo quirúrgico el 23/07 con Hartmann. Nuevo aseo quirúrgico el 25/07 y posteriormente cierre de laparotomía media con ileostomía terminal el 28/07.

Gastrointestinal: con elevación progresiva de pruebas hepáticas en patrón predominantemente colestásica, sin hiperbilirrubinemia asociada. Impresiona compatible con DILI colestásico, ¿secundario a betalactámicos? ¿Vancomicina?, evaluar con infectología ajuste de terapia.

Nefrológico: con injuria renal KDIGO II séptica, recupera con volemización.

Nutricional: con requerimientos nutricionales aumentados. Se inicia NPTC pero tras reconstitución de tracto gastrointestinal se mantiene con aportes enterales según requerimientos. Evoluciona con hipocalcemia severa como manifestación de síndrome de realimentación, se maneja con Cloruro de Calcio EV.

Medio interno: con acidosis metabólica AG aumentado hiperkalémica. Impresiona acidosis tubular renal tipo 4, se difiere estudio por el momento.

Diagnósticos actuales:

Shock séptico de foco abdominal refractario

Peritonitis estercorácea - perforación intestinal neoplásica

- 23/07: aseo quirúrgico con colostomía de Hartmann

- 25/07: aseo quirúrgico

- 28/07: aseo quirúrgico, cierre laparotomía, ileostomía terminal.

- Cultivo LP (+) E. faecium MS + Bacillus spp.

- Sospecha de infección fúngica invasora, Candida Score 3 puntos

Alteración de pruebas hepáticas en patrón colestásico - ¿DILI a carbapenémicos v/s Vancomicina?

Desnutrición calorico-proteica crónica - alto riesgo de síndrome de realimentación

- Hipocalcemia severa resuelta

- Hipokalemia leve en resolución

Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica resuelta

Injuria renal aguda KDIGO II resuelta

Acidosis metabólica AG normal obs. acidosis tubular renal tipo 4

Cáncer de ovario met astásico, carcinomatosis peritoneal

Antecedentes

Ingres a sala básica de cirugía el 17/08.

Evoluciona con reacción adversa a medicamentos (obs vancomicina vs imipenem) tipo DRESS, manejada con altas dosis de hidrocortisona y corticoides tópicos. Evoluciona favorablemente con decalaje progresivo de corticoides. Persistencia de elevación de pruebas hepáticas con patrón colestásico.

Infeccioso: se suspenden ATB en contexto de RAM, sin nuevas reinfecciones

Renal: evoluciona con alteración leve de la función renal (última Crea 1.6) obs prerrenal en contexto de altos débitos por ileostomía que se manejan con loperamida e hidratación endovenosa.

Quirúrgico: con dehiscencia de laparotomía que se maneja con curaciones, aseo quirúrgico y VAC que filtra desde ileostomía por lo que se mantiene con curaciones evolucionando favorablemente, reduciendo el tamaño de la herida hasta 5mm x 5 mm al momento del alta.

Oncológico: se presenta caso en comité oncológico, se decide mantener cuidados paliativos en su hospital de base.

Diagnóstico de Egreso

PERITONITIS AGUDA - Fecaloidea 4 cuadrantes. Tumor sigmoides perforado.

OTRA REACCIÓN ADVERSA A ALIMENTOS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE - Reacción adversa a medicamentos

Desnutrición proteico-calórica, no especificada -

Fecha Epicrisis : 06/11/2022 17:54

Página 2 de 3

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 06-11-2022 17:54:30

Página 3 de 3

ANEMIA EN EFERMEDADES CRONICAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE -
TUMOR MALIGNO DEL ENDOMETRIO -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buenas condiciones generales

Plan Post Alta

Reposo relativo, levantarse todos los días
Regimen hiposodico; 1-1.5 L de agua al día
Paracetamol 500 mg 2 comp cada 8 hrs por 7 días
Amlodipino 10 mg cada día a permanencia
Hidralazina 50 mg cada 8 hrs a permanencia
Loperamida 4 mg cada 6 hrs a permanencia
Clorfenamina 4 mg cada 8 hrs por 7 días SOS en caso de prurito
Acudir a Unidad de Cuidados Paliativos para notificar alta y solicitar hora de control.
Control con Dra Galaz en CDT pasillo 11 el 22 de noviembre a partir de las 13 hrs, pedir hora.
Acudir a urgencia en caso de dolor que no cede con analgesicos, fiebre, incapacidad para mantenerse hidratada o en caso de
estimar necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : .

Régimen Alimentario : .

Medicamentos :

Controles

INTERNO



Becado/Residente

Becado/Residente



Valeria Galaz Kutulas

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 06/11/2022 17:54

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:23

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar